**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

**Autos: 0840163-78.2020.8.12.0001**
**Ação: Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar (Planos de Saúde)**
**Autor:Rafael Lin Rodrigues**
**Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**

Vistos...

**Rafael Lin Rodrigues**, representado pela genitora Cristiane Sefer Lin, ajuiz*ou ação de obrigação de fazer c.c tutela de urgência* em desfavor de **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**.

A parte requerente é beneficiária, na modalidade dependente, do plano de saúde individual familiar gerido pela parte requerida. Em razão de doença diagnosticada – transtorno do espectro autista – TEA (CID 10 F.84), a médica assistente Maria Eulina Quilião, CRM/MS 3216, indicou o seguinte tratamento com equipe multidisciplinar (f. 02):

> (...) TERAPIA PELO MÉTODO ABA: 5 vezes na semana, sessão de 2 horas/dia, por tempo indeterminado; TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA ESPECIALIZADA EM LINGUAGEM E EM TEA COM APERFEIÇOAMENTO EM ABA: 3 vezes na semana, sessão de 40 minutos, por tempo indeterminado; TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL: 3 vezes na semana, sessão de 40 minutos, por tempo indeterminado. *(sic)*

Em razão da urgência e da necessidade de dar início e sequência às terapias indicadas, e por não ter condições de arcar com os custos dos tratamentos, a sua genitora solicitou da parte requerida autorização dos tratamentos prescritos. Contudo, a parte requerida negou a cobertura do tratamento ABA, por não estar previsto no rol de procedimentos e eventos de saúde; propôs o reembolso do tratamento, limitado ao valor de R$32,19 por sessão/dia; autorizou uma sessão de terapia ocupacional convencional e dez sessões de fonoaudiologia convencional, sem as especializações necessárias.

A requerida indicou e forneceu lista de profissionais e clínicas, sem comprovar a especialidade solicitada, pois as clínicas e profissionais informados não possuem a especialidade que necessita.

Não solicitou atendimento por profissionais fora da rede credenciada da parte requerida, e sim autorização do tratamento conforme prescrito pela médica, o que foi negado pela parte requerida, sob o fundamento de não existir cobertura contratual.

Assim pediu (f. 27-9):





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

(...); a) a concessão inaudita altera pars da tutela de urgência no sentido de determinar que a demandada garanta, autorize e forneça os tratamentos ao requerente conforme prescrições médicas, sendo: TERAPIA PELO MÉTODO ABA:5 vezes na semana, sessão de 2 horas/dia, por tempo indeterminado, TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA ESPECIALIZADA EM LINGUAGEM E EM TEA COM APERFEIÇOAMENTO EM ABA: 3 vezes na semana, sessão de 40 minutos, por tempo indeterminado e TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL: 3 vezes na semana, sessão de 40 minutos, por tempo indeterminado, pelo tempo e intensidade indicados pela médica e profissionais que assistem o demandante e sem limitação de sessões com os profissionais que já atendem o autor, uma vez que a requerida não possui rede credenciada e que a troca de profissionais pode causar prejuízos ao menor, devendo o pagamento ser realizado integralmente e diretamente aos profissionais que atendem o autor sem que o requerente necessite adiantar esses pagamentos, visto que não tem condições financeiras, até que a médica a determine a interrupção dos tratamentos, no prazo mais exíguo possível a contar de sua intimação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, conforme disposto no artigo 536, §1º, do CPC, que poderá ser majorada se for o caso e sem prejuízo de outras medidas assecuratórias; (...); i) no mérito, requer sejam julgados totalmente pro-cedentes os pedidos para o fim de: seja presente de-manda JULGADA INTEIRAMENTE PROCEDENTE, a fim de ser condenada a Requerida a providenciar ao Requerente, periodicamente, os tratamentos supramencionados, através da prestação de serviços de saúde necessários para sua habilitação e conforme prescrito pela médica assistente; bem como seja, ressalvando, ainda, a possibilidade de alteração de quantidade, periodicidade do tratamento, mediante justificativa médica prévia e ao final, confirmada a tutela antecipada concedida anteriormente; *(sic)*

Anexou documentos (f. 30-188).

Tutela de urgência deferida (f. 190-5).

Comunicação de cumprimento da liminar (f. 206-9).

A parte requerida contestou (f. 248-76) pleiteando a improcedência dos pedidos, pois o contrato é adaptado à Lei 9.656/98, e, portanto, vinculado ao rol da ANS. O tratamento ABA não possui cobertura contratual. Informou que aos 20 de outubro de 2020 criou o núcleo Viver Bem especializado em ABA.





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

Em 22/10/2020, a genitora da parte requerente compareceu ao Viver Bem para verificar autorização do ABA e não retornou ao setor responsável para solicitar Fonoaudilogia e Terapia Ocupacional com especialidade. Aos 04/11/2020, a parte requerente compareceu ao atendimento com o pedido médico de fonaudiologia com especialidade em linguagem e terapia ocupacional com integração sensorial.

Argumentou que propôs avaliação e tratamento no Centro especializado em TEA – Transtorno do Espectro Autista da Unimed Campo Grande (serviço próprio), para estímulo e acompanhamento de equipe multidisciplinar (fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga) especializada em autismo, com terapias cobertas pelo plano e que trazem a mesma evolução clínica que o método ABA pleiteado, sendo tão eficazes quanto. Contudo, a médica assistente especialista informou que o método não era eficaz.

Quanto às sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional, possuem profissionais capacitados para tanto e qualquer profissional formado na área, com especialização direcionada às necessidades do paciente, capaz de prestar o atendimentos e atingir os objetivos almejados, não subsistindo a tese de obrigatoriedade de certificação para comprovar a capacidade técnica do terapeuta.

O contrato pactuado entre as partes, com a disposições das coberturas, está encampado por meio da legislação pertinente (CC, art. 757), da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e nas cláusulas contratuais, ou seja, agiu dentro de seu exercício regular de direito.

Juntou documentos (f. 277-442).

Tentativa de conciliação infrutífera (f. 445).

Réplica (f. 448-69) e anexação de documentos (f. 470-547).

A parte requerida agravou a liminar deferida e o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (f. 653-73).

Na decisão de saneamento (f. 674-6), o juízo fixou os pontos controvertidos, delimitando o ônus da prova, deferindo-se a perícia médica (f. 689-90) e indeferindo a prova oral.

Colacionado o laudo (f. 780-93).





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

A parte requerida concordou com as conclusões da médica avaliadora (f. 796-8), anexando parecer do assistente técnico (f. 799-827).

A parte requerente impugnou o parecer da perita, que demostrou parcialidade nas suas conclusões, notadamente acerca da possibilidade do tratamento ser efetivado por meio dos profissionais integrantes da rede credenciada da parte requerida. Anexou novo laudo médico (f. 833).

Nova tentativa de conciliação infrutífera (f. 854).

Parecer ministerial pela homologação do laudo (f. 861).

As partes ofertaram alegações finais escritas, reiterando as teses defensivas iniciais (f. 870-6 e 877-83), ao passo que o Ministério Público requereu a procedência parcial dos pedidos, mantendo os tratamentos deferidos na liminar, com os profissionais disponibilizados na rede credenciada da parte requerida (f. 887-90).

**É o relatório. Passo a decidir.**

Em saneamento, o juízo fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova (f. 674-6):

> É incontroverso nos autos a relação contratual entre as partes e que há cobertura contratual para tratamento do Transtorno de Espectro Autista - TEA – de que é portador o autor. Incontroverso, outrossim, que a requerida detém obrigação contratual de fornecimento da fonoterapia e terapia ocupacionalao autor, o que já vem fazendo regularmente, por meio da sua rede credenciada. O primeiro ponto de fato controvertido nos autos é a imprescindibilidade do tratamento de reabilitação do autor mediante o método ABA, em 10 horas semanais, com acompanhamento por aplicador, ou se existem outros métodos/especialidades de tratamento igualmente eficazes e que constam no rol da ANS, disponibilizados pela ré. Ônus da prova: Mantenho a distribuição ordinária do nus da prova, cabendo ao autor comprovar a imprescindibilidade do tratamento pelas especialidades terapêuticas pleiteadas, e ineficácia do tratamento coberto pelo plano de saúde réu, na sua rede credenciada (art. 373, inciso I, do CPC). Provas admitidas: Prova técnica simplificada, consistente na oitiva de profissional especialista na área médica do transtorno de que é portador o autor.





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

Restou incontroverso que a parte requerente é beneficiária do plano de saúde gerido pela parte requerida, na condição de dependente, e que é portadora de transtorno do espectro autista – TEA (CID 10 F.84), consoante relatório da neurologista especialista Maria Eulina Quilião, CRM/MS 3216 (f. 43):

> CG/MS, 22/10/2020
>
> Rafael Lin Rodrigues, com atraso na fala (sem atraso motor), alguns sinais sugestivos de TEA. RNM e aval auditiva normal.
>
> Solicito urgente inclusão em TERAPIA OCUPACIONAL, especialista em integração sensorial, 3x/semana, por tempo indeterminado
>
> A Urgencia deve-se ao fato de termos que aproveitar da janela terapêutica/plasticidade cerebral (3-4anos), para melhorar prognostico.
>
> CID: F84

Em razão da doença diagnosticada, a médica especialista indicou o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados (f. 43-5):

> TERAPIA PELO MÉTODO ABA: 5 vezes na semana, sessão de 2 horas/dia, por tempo indeterminado; TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA ESPECIALIZADA EM LINGUAGEM E EM TEA COM APERFEIÇOAMENTO EM ABA: 3 vezes na semana, sessão de 40 minutos, por tempo indeterminado; TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL: 3 vezes na semana, sessão de 40 minutos, por tempo indeterminado.

A parte requerente formulou pedido administrativo perante à parte requerida, a fim de obter o tratamento iniciado e com as profissionais que já atendiam o paciente quando do diagnóstico, uma vez que a parte requerida não dispunha de equipe especializada para tanto. Todavia, a parte requerida negou a cobertura da terapia pelo método ABA e autorizou as terapias ocupacionais convencional e fonoaudiologia sem especialidade (f. 71-80):





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

| Dados da Solicitação |
|---|
| Paciente<br>Rafael Lin-Rodrigues |
| Descrição da Solicitação<br>Análise Comportamental Aplicada - ABA |

Informamos que a solicitação acima discriminada **não está prevista no rol de cobertura (rol de procedimentos e eventos de saúde)**, no entanto, **por liberalidade**, esta operadora de plano de saúde propõe o reembolso das respectivas despesas, **limitado ao valor de R$32,19** (trinta e dois reais e dezenove centavos) por sessão/dia.

Oportuno esclarecer que a Unimed Campo Grande visando à necessidade de atendimento aos beneficiários portadores de TEA (Transtorno Espectro Autista), criou um avançado centro de terapias multidisciplinares com profissionais capacitadas, sem, no entanto, tratar-se da aplicação do método ABA, o qual não é a única terapia comprovada cientificamente para o transtorno. Frisa-se que todas as terapias multidisciplinares utilizadas pelo projeto possuem cobertura no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, oportunidade esta que é oferecida à Vossa Senhoria.

Todos os conceitos e condições acima expostos constam de forma explícita nas cláusulas que integram o Contrato firmado por Vossa Senhoria.

Pelas razões acima expostas, a solicitação apresentada por Vossa Senhoria **não possui cobertura contratual**, mas apesar disso, **emite-se a presente proposta de reembolso por liberalidade**, nos termos e condições acima constantes. A legislação e as normas citadas acima podem ser consultadas no sítio oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (www.ans.gov.br).

A terapêutica fora prescrita pela médica responsável para o tratamento da doença que acomete a parte requerente, ressaltando, inclusive, a urgência do caso, a fim de evitar danos neurocognitivos irreversíveis, considerando-se a terna idade do paciente (dois anos e oito meses). Logo, afigura-se despropositada a negativa de disponibilização do tratamento para reversão do quadro de saúde apresentado (f. 47):





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

4.Quais as vantagens do tratamento proposto para o(a) paciente para sua moléstia?:
A especialidade e urgencia da instituição da terapia, deve-se ao fato de termos que aproveitar da janela terapêutica/plasticidade cerebral (3-4anos), para melhorar prognostico.

Cabia à parte requerida comprovar que dispunha de equipe multidisciplinar com especialidade necessária para dar continuidade ao tratamento já iniciado pela parte requerente e prescrito pela médica especialista. Entretanto, não trouxe provas nesse sentido (CPC. art. 373, II).

Aliás, na contestação, reforçou a negativa sob o pretexto do contrato ser adaptado à Lei 9.656/98, e, portanto, vinculado ao rol taxativo da ANS, de modo que o tratamento solicitado (ABA) não possui cobertura contratual, especificando que a ANS permite que os procedimentos sejam executados por qualquer profissional de saúde habilitado para tanto sem necessidade de especialização. Contudo, cabe ao profissional de saúde, que conhece todo o histórico do paciente e suas necessidades, definir o tratamento mais indicado ao caso clínico, sem limitação, conforme as recentes alterações da Lei 9.656/98, por meio da Lei 14.454/2022:

> (...). **Nos contratos de plano de saúde, diante da expressa indicação médica, deve ser realizado o tratamento especializado indicado ainda que fora da rede credenciada e do limite estabelecido no contrato. Além disso, como a partir de 1º de julho de 2022, por meio da Resolução Normativa n. 532/2022 da ANS, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças, não há como o plano de saúde se recusar ao fornecimento do tratamento.** Agravo conhecido e provido, com o parecer. *(TJMS; AI 1407236-42.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 22/07/2022; Pág. 55)*

O rol da ANS aponta coberturas **mínimas** como orientação a serem observadas pelos planos de saúde, não impedindo a ampliação para oferecer o tratamento pertinente, à luz das alterações da Lei 9.656/98, por meio da Lei 14.454/2022.





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

Conquanto as alterações da lei sejam posteriores ao diagnóstico da parte requerente (2020), os contratos de planos de saúde estão submetido ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 9656/98, art. 35), principalmente porque envolvem relação de consumo. Assim, *in casu*, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor (CDC, art. 47), de modo que a parte requerida não pode recusar o custeio do tratamento prescrito pela médica assistente, que, reitero, é responsável por definir o melhor tratamento para o paciente. Além disso, o que importa é a existência de cobertura para a doença apresentada pela parte requerente, e não a forma como o tratamento será ministrado.

Portanto, uma vez inclusa determinada patologia no rol de doenças ou acidentes cobertos, como, *in casu*, afasta-se a possibilidade de estabelecer "normas" que excluam o tratamento integral, pois, admitir a cobertura parcial, seria o mesmo que autorizar a prestação de um serviço defeituoso e inservível:

Deferida a prova pericial, a médica nomeada confirmou o diagnóstico e o tratamento indicado pela médica assistente e, apesar de afastar a urgência do caso (f. 791), reforçou a necessidade de aproveitar a oportunidade de estimulação do desenvolvimento neurológico até os três anos de idade (f. 784 e 786-8):

> **No caso em tela, o periciado foi avaliado por neurologista infantil com diagnóstico de transtorno do espectro autista . Segundo o DSM5, quanto ao grau de gravidade do transtorno, o periciado é classificado no nível 1 e não apresenta outras doenças neurológicas ou síndromes.**
>
> **2- Do tratamento preconizado**
>
> Qualquer programa de estimulação do desenvolvimento da criança deve ter seu início no período que engloba desde a concepção até os três anos de idade. Esta é a fase em que o cérebro se desenvolve mais rapidamente, constituindo uma janela de oportunidades para o estabelecimento das funções que repercutirão em uma boa saúde e produtividade no futuro (UNICEF, 2015).
>
> **No caso em tela, desde a época do diagnóstico, o periciado faz tratamentos e acompanhamentos com médico neurologista pediátrico, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional.**





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

**4- Do tratamento realizado pelo periciado**

Segundo informação da genitora, o periciado faz tratamento com equipe multidisciplinar com intervenção diária de ABA, fonoaudiologia 3x e terapia ocupacional 3x.

Há de se notar os relatórios evolutivos do periciado, nas áreas de terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia, que mostram uma evolução satisfatória do desenvolvimento com os tratamentos instituídos.

De fato, a evolução esperada para os casos de TEA classificado como nível 1, como é o caso em tela, é de melhora mais evidente quando comparada com aqueles que apresentam formas mais graves do transtorno.

**Conclusão**

Diante do exposto, destituída de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos exames complementares e nos laudos médicos e receitas médicas constantes nos autos e os apresentados durante a perícia, posso concluir afirmando que o periciado é portador de:

- Transtorno do espectro autista nível 1 CID 10 F84
- Há indicação de manutenção do tratamento por equipe multidisciplinar

A perita informou que a parte requerida possui centro especializado – Unidade de Terapia do TEA – Viver Bem, com equipe de profissionais nas áreas de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e fisioterapia, inclusive pelo método ABA (f. 787-8, 790-2):

**No caso em tela, pode ser constatado que o periciado nunca se submeteu ao tratamento com profissionais credenciados pela rede da parte ré.**

**Esta perita já visitou a Unidade de Terapia do TEA, oferecido pela parte ré aos seus usuários, que conta com espaço próprio e equipe de profissionais nas**





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

**áreas da fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e fisioterapia, que são habilitados e credenciados para atuar nas diversas áreas específicas e no tratamento dos portadores de TEA, inclusive pelo método ABA.**

**Desse modo, do ponto de vista médico, não há elementos para se concluir que a melhora do desenvolvimento observada no periciado, também não seria obtida se o mesmo tivesse realizado o tratamento pelos profissionais da rede credenciada.**

3- A requerida possui profissionais credenciados com as especializações que o requerente necessita? **Sim.**

4- Quais serão as consequências caso seja suspenso os tratamentos que o autor está atualmente realizando? A troca de profissionais pode causar danos ao menor? **A troca de profissionais provavelmente não causaria danos, uma vez que o periciado interage facilmente. Também não há relatos na literatura médica científica de que este fato causaria prejuízo ao desenvolvimento neurofuncional do menor.**

5- A questão da adaptação com o profissional é relevante no caso de crianças portadoras de TEA? **Não há referências científicas que comprovem tal fato. Tais profissionais são preparados para justamente estabelecer vínculos adequados na abordagem destas crianças.**

9- A Unimed oferece em seu rol profissionais capacitados pelos respectivos órgãos de classe responsáveis para o atendimento ao periciando? **Sim.**

10- A Unimed ofereceu tratamento especializado para o caso do periciando em centro de tratamento para TEA - Projeto TEA/UNIMED? **Sim.**

Sucede que a parte requerente trouxe laudo atualizado da médica assistente reforçando a necessidade de manutenção das terapias com a equipe multidisciplinar contratada desde 2020, a fim de evitar a regressão do seu quadro de saúde, tendo em vista o estabelecimento de vínculo e confiança entre paciente/terapeuta (f. 833):





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

3. ABA, 2h/dia, 5x/semana, por tempo indeterminado

Ressaltamos que a importância da intervenção continua e ininterrupta, está associada à plasticidade cerebral, momento onde, quando adequadamente estimulado, por profissionais habilitados e capacitados, temos reconexões cerebrais, levando ao objetivo de termos uma melhora de excelência no prognostico. Lembrando que o objetivo é que tenhamos um adulto funcional. Observamos grandes avanços, certamente devido ao fato de termos aproveitado a janela terapêutica/plasticidade cerebral (3-4anos) e profissionais capacitados.

É de fundamental importância manter os terapeutas já instituídos, porque o vinculo neste individuo em especial, é dificil se ser conquistado, sendo que a substituição do profissional leva invariavelmente a involução, com perda de aquisições, duramente conquistadas.

A substituição destes profissionais leva certamente a prejuízos efetivos para a criança, com danos a longo prazo.

Ressalto ainda que as terapias usuais, oferecidas pelo convenio já foram exaustivamente tentadas pela família, sem qualquer evolução significativa.

CID10: F84
CID11: 6A02.0

Além disso, as conclusões da perita, conquanto sejam sempre muito lúcidas, não vinculam o juízo, mesmo porque a própria reconhece que o tratamento indicado teve avanços significativos comunicação social e relacionamento interpessoal da parte requerente:

> **CPC, Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.**
>
> **(...) INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL. (...).** 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial em virtude do princípio da livre convicção, caso as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito. 6. Agravo Interno não provido. *(STJ; AgInt-AREsp 2.176.843; Proc. 2022/0230601-6; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)*

Some-se a isso, apesar de alegar possuir centro especializado – Viver Bem, a parte requerida não apresentou de maneira célere e eficaz os profissionais que realizassem o tratamento da maneira prescrita pela médica assistente, o qual era urgente para a parte requerente. Inclusive, na contestação, limitou-se a colacionar relação de profissionais que atendem pela rede credenciada (f. 318), sem indicar quais possuem a especialidade solicitada para o *método ABA; fonoaudiológica especializada em linguagem e em TEA com aperfeiçoamento em ABA; e, terapia ocupacional especializada em integração sensorial:*





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

(...). **II. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a cura ou melhora do quadro de saúde do paciente. Assim sendo, à vista de expressa indicação do médico que assiste o paciente, torna-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS. III. Caso o plano de saúde não possua profissionais credenciados, é possível a prestação de serviço por profissionais fora da rede credenciada, conforme autoriza o art. 4º da RN 259 da ANS, circunstância que, inclusive, substancia fundamento idôneo para a manutenção da improcedência do pedido subsidiário de eventual reembolso com base na tabela prevista na Lei n. 9.656/98.** (...). V. Recurso da Unimed conhecido e parcialmente provido, apenas para redistribuir o ônus da sucumbência. VI. Recurso do Autor conhecido e desprovido. *(TJMS; AC 0823536-62.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 03/06/2024; Pág. 318)*

(...). 3. Hipótese em que as peculiaridades do caso demonstram a necessidade do tratamento multidisciplinar indicado pelos profissionais que acompanham a parte autora, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente caso o tratamento não seja fornecido. 4. Rol de procedimentos da ans. Rol exemplificativo. Precedentes. **5. Para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares com profissional médico e em estabelecimento não credenciados, ou fora da área de abrangência, é necessário que demonstre se tratar de situação de urgência e emergência, de impossibilidade de utilização da rede credenciada da empresa de plano de saúde, de indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, de falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento na rede. Hipótese em que as peculiaridades do caso demonstram a necessidade de manutenção do tratamento multidisciplinar com os profissionais que acompanham a criança, portadora de autismo, sob pena de ocorrência de graves danos à saúde.** 6. Fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o proveito econômico obtido, conforme recente alteração legislativa e jurisprudência do c. STJ. Apelação desprovida e recurso adesivo provido. *(TJRS; AC 5106467-55.2020.8.21.0001; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 27/07/2022; DJERS 27/07/2022)*





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

A parte requerida sequer comprovou a eficácia dos métodos tradicionais disponibilizados na rede credenciada, pois, como visto, na perícia judicial, embora a perita tenha confirmado a existência de diversos tratamentos, que sequer se sabe se seriam igualmente eficazes, confirmou o acerto da terapia pelo método ABA, indicada pela médica assistente (f. 788 e 791):

> 5- Existem outros tratamentos para o caso clínico do periciando, ou seja, existem terapias alternativas? **Sim. Segundo a literatura científica não há evidências de superioridade entre um e outro método terapêutico, embora o método ABA seja amplamente utilizado.**
>
> **Conclusão**
>
> Diante do exposto, destituída de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos exames complementares e nos laudos médicos e receitas médicas constantes nos autos e os apresentados durante a perícia, posso concluir afirmando que o periciado é portador de:
>
> - Transtorno do espectro autista nível 1 CID 10 F84
> - Há indicação de manutenção do tratamento por equipe multidisciplinar

Desse modo, cabível a manutenção das terapias com as profissionais que atendem a parte requerente, quais sejam, *terapia pelo método ABA, 5 vezes na semana, sessão de 2h/dia; terapia fonoaudiológica especializada em linguagem e em TEA com aperfeiçoamento em ABA, 3 vezes na semana, 40min/dia; terapia ocupacional especializada em integração sensorial, 3 vezes na semana, 40min/dia, todas por tempo indeterminado*, a serem custeadas integralmente pela parte requerida, conforme já determinado por meio da liminar (f. 192-5).

**Diante do exposto**, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para que a parte requerida forneça e custeie o tratamento multidisciplinar contínuo prescrito pela médica assistente (f. 43-5), pelo tempo necessário e com as profissionais que já lhe atendem, ratificando-se integralmente a liminar anteriormente deferida.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.

**Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul**

**Comarca de Campo Grande**

**14ª Vara Cível**

Sucumbente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 12% (doze porcento) sobre o valor atualizado da causa pelo IPCA/IBGE, do ajuizamento da demanda, tendo em vista a inexistência de dados acerca do valor integral do tratamento, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, em especial pela duração do processo e realização de perícia.

Publique-se Registre-se. Intimem-se.

Campo Grande, *(data e assinatura à margem direita do documento).*

**Marcus Vinícius de Oliveira Elias**
**Juiz de Direito**





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 11/09/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840163-78.2020.8.12.0001 e código 9neWzCQt.